

一领域的独特认识和精辟见解。《难经》拓展了《黄帝内经》治未病的概念,提出了“治未病者,见肝之病当传之于脾,故先实其脾气,无令所受肝之邪,故曰治未病也”的认识,已明确增添了既病防变的思想。张仲景发展了《黄帝内经》以来的相关思想,在《金匮要略》的开篇即问:“上工治未病,何也?”接着从未病先防、既病防变的多侧面论述了治未病的原理、方法,不仅有“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”的理论,而且有“但见一症便是,不必悉具”的经验和“益用甘味之药调之”的实践。在《伤寒杂病论》一书中,治未病已经形成了完整的学说,养生保健,均有涉猎;治则方药,一应俱全。孙思邈将疾病分为“未病”、“欲病”、“已病”三个层次,要求医生要“消未起之患,治未病之疾,医之于无事之前”。在《千金》两方中,他还明确论证了治未病与养性的直接关系:“喜养性者,治未病之病”,创造了一整套养生延年的方法。朱丹溪对治未病也有高明的认识,说:“已病而后治,所以为医家之法;未病而先治,所以明摄生之理。”叶天士未雨绸缪的思想,又较前进一步,他提出的“务在先安未受邪之地”的观点,是疾病过程中防变于先的主动措施。

中医指的“未病”,不仅是指机体处于尚未发生疾病时段的状态,而且包括疾病在动态变化中可能出现的趋向和未来时段可能表现出的状态。通常认为,它包括未病先防、既病防变和病后康复三个方面,反映于疾病微而未显(隐而未现)、显而未成(有轻微表现)、成而未发(有明显表现)、发而未传(有典型表现)、传而未变(有恶化表现)、变而未果(表现出愈或坏、生或死的紧急关头)的全过程,是一个复杂的系统工程。在这个过程的每一个环节上,都有文章可做,都可以根据疾病发生、发展、传播、转化的规律采取使疾病朝正向逆转的

措施,都有医者施展才华的机遇。通过养精调神,铸就健康支柱、合理饮食,打造健康基石、强身健体,增添健康动力、科学用药,充实健康保障的综合运作,达到防病强身的目的。现代所谓的“亚健康”状态,仅是中医未病中部分阶段的表现,即疾病微而未显、显而未成的时期,而不能包括中医未病说的全部。换句话说,中医的治未病说,针对的不仅仅是亚健康状态,而是包括亚健康状态在内的、具有更广泛意义的大健康学说。

中医治未病说的意义除表现在健康学之外,其社会学意义也非常重大。作为一个尚不富裕的发展中国家,如何解决经济实力与人民健康的关系问题是我们必须面对的涉及国计民生的重大课题。在这方面,一些发达国家的教训已足可引起我们的借鉴:以美国为例,20世纪50年代中期至1975年间,他们虽然在诸如心脏手术、脊髓灰质炎疫苗、冠脉搭桥等一系列新医疗技术上有很大发展,但也同时引起医疗费用的大幅度增加(由原来的120亿美元增至1185亿美元,年增长率高达96%),而患者的死亡率却未能明显下降(一直保持在7~8%之间的“停滞期”内)。70年代中期之后,美国开展了类似于中医治未病说内容的以“合理膳食,适量运动,戒烟限酒,心理平衡”为基石的全民健康教育,结果很快取得了成效,至1996年,高血压发病率下降了55%,脑卒中下降75%,糖尿病减少50%,肿瘤减少1/3,人均预期寿命明显延长了,而用于这方面的费用仅为此前同时期的1/10。因此,一些社会学和经济学家把“治未病”说称为“供得起和可持续的医学”。

病未发,防微杜渐;病既成,把握进退;病痊愈,慎防劳复;莫等亡羊补牢,力求事半功倍。这是否是中医治未病说的基本意义,有必要做进一步的研究和探讨。

(本文校对:韩世辉 收稿日期:2012-01-05)

杨建宇二十四节气养生歌赏析(五)※

——惊蛰养生

王志华 李彦知 杨建宇[△]

(中国中医药现代远程教育杂志社,北京100021)

关键词:二十四节气;惊蛰;养生歌诀;赏析

doi: 10.3969/j.issn.1672-2779.2012.05.070

文章编号:1672-2779(2012)-05-0101-02

[歌诀] 惊蛰闻雷万物长,调达肝气和阴阳,多练静功防冷风,温补忌怒肝脾祥,少酸多甘温不燥,多食野菜保安康。

1 原文解释

惊蛰时“春雷响,万物长”,养生要重视调达肝气、

平衡阴阳。饮食上宜少吃酸味、多吃甘味食物以健脾,适当食温热食物以壮阳御寒,多食野菜亦有利于健康;选择慢跑、太极拳、放风筝、坐功等较柔和的运动方式;精神上注意调节情绪,切忌妄动肝火。

2 节气特点

惊蛰是二十四节气中的第三个节气,时值每年农历3月6日前后,太阳到达黄经345°时。“惊”是惊醒、惊动之意;“蛰”是“蛰伏”之意。“惊蛰”的意思是说春雷始鸣,惊醒了蛰伏于地下冬眠的昆虫。《月令七

※基金项目:世中联(北京)远程教育科技发展中心十二五攻关项目
[No: SZ125008]

[△]指导老师

十二候集解》中说：“二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”我国古代将惊蛰分为三候：“一候桃始华，二候仓庚(黄鹂)鸣，三候鹰化为鸠”，指出此时蛰伏在泥土中冬眠的各种昆虫开始惊醒，过冬的虫卵也要开始卵化。由此可见，惊蛰是反映自然物候现象的一个节气。按照一般气候规律，惊蛰前后各地天气已开始转暖，雨水渐多，我国华北地区日平均气温上升至3~6℃，江南一带气温升至8℃以上，西南、华南地区气温一般可达到10~15℃。与其他节气相比，惊蛰时的气温回升是全年最快的。

3 养生要点

3.1 起居养生 惊蛰后天气逐渐转暖，但冷空气活动仍较频繁，有时还会出现“倒春寒”现象。因此，惊蛰时人们还不可急于换上春装，尤其是老年人，更应时刻关注天气预报，注意根据天气冷暖变化及时增减衣服。

进入惊蛰以后，随着天气转暖，人们时常会感到困倦无力、昏昏欲睡，这也就是民间所说的“春困”。之所以出现“春困”，是因为人体的皮肤在冬天里受到寒冷刺激，毛细血管收缩，汗腺和毛孔闭合。随着惊蛰时气温慢慢升高，人体皮肤的毛孔、汗腺和血管也逐渐舒张，所需要的血液供应增多，汗腺分泌也增多。但人体内血液的总量是相对稳定的，供应外周的血液增多了，供应给大脑的血液就会相对减少。加之暖气温度的良性刺激，使大脑受到某种抑制，人们就会出现“春困”现象。为了避免此情况的发生，惊蛰时人们应每天保证充足的睡眠时间。《黄帝内经》曰：“春三月，此谓发陈。天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以使志生。”意思是说，春天晚睡早起、慢步缓行可以使精神愉悦、身体健康。

3.2 饮食养生

3.2.1 适当多吃温热健脾食物 惊蛰时天气虽然有所转暖，但余寒未清，在饮食上宜多吃些温热的食物以壮阳御寒，如韭菜、洋葱、大蒜、魔芋、香菜、生姜、葱等，这些食物性甘味辛，不仅可祛风散寒，而且能抑制春季病菌的滋生。另外，惊蛰时还应遵循“春日宜省酸增甘，以养脾气”的养生原则，多吃些性温味甘的食物以健脾，这些食物包括糯米、黑米、高粱、燕麦、南瓜、扁豆、红枣、桂圆、核桃、栗子等。

3.2.2 多食野菜益健康 惊蛰以后，野菜陆续上市。野菜吸取大自然之精华，其营养丰富，有些本身就是药材，多食有益健康。如①荠菜：荠菜是最早报春的时鲜野菜，其味甘，性平、凉，入肝、肺、脾经。可凉血止血、清热利尿，能防治多种出血性疾病，如血尿、妇女功能性子宫出血、高血压患者眼底出血、牙龈出血等，对于干眼病、夜盲症、胃痉挛、胃溃疡、痢疾、肠炎等症有特殊功效，另外有助于防治高血压、冠心病、肥胖症、糖尿病、肠癌及痔疮等。荠菜可炒食、凉拌、做馅等。②二月兰：二月兰又名诸葛菜，为早春常见野菜，嫩叶和茎均可食用，且营养丰富。据测定，每100g鲜二月兰中含胡萝卜素3.32mg、维生素B₂ 0.16mg、维生素C 59mg。二月兰采后只需用开水焯一下，去掉苦味

即可食用。③蒲公英：蒲公英性寒，味甘、微苦，具有清热解毒、消肿散结的功效。可防治上呼吸道感染、眼结膜炎、流行性腮腺炎、乳痈肿痛、痢疾、泌尿系感染、盆腔炎、痈疖疔疮、咽炎等，可生吃、炒食、做汤、炆拌、做馅等。

3.3 运动养生 惊蛰过后，自然界呈现复苏之势，人也同自然界其他生物一样，身体各脏器的功能都还未恢复到最佳状态，特别是关节和肌肉还没有得到充分的舒展，因此此时不宜进行激烈的运动，应选择走路、慢跑、太极拳等比较和缓的运动方式。另外，放风筝也是特别适合在春天里进行的一种运动，大家不妨一试。因为冬季里人们久居室内，趁惊蛰阳气生发之际，到旷野郊外去放放风筝，可以在享受大自然美景的同时，使身体各部位得到锻炼，加快人体血液循环，促进新陈代谢，使机体顺应自然界阳气生发的特点。

惊蛰时也可练坐功以养生。具体方法是：每天清晨，盘腿坐，两手握拳。头顶向左右缓缓转动各4次。两肘弯曲，前臂上抬至与胸齐平，手心朝下，十指自然拳曲。两肘关节同时向后顿引，还原，如此反复做30次，然后上下齿相叩，即叩齿36次，漱津几次，待津液满口分3次咽下，意想把津液送至丹田。如此漱津3次，一呼一吸为一息，如此36息而止。常练此功法可改善腰脊脾胃蓄积之邪毒、目黄口干、齿鼻出血、头风面肿、喉痹、暴哑、目暗畏光等证。

3.4 情志养生 惊蛰时人体的肝阳之气渐升，阴血相对不足，容易发生肝火偏盛。尤其是老年人，易发怒，易发眩晕、中风等疾病。年轻人则因春季阳气骤然上升引动体内热气，如果此时控制不好自己的情绪，则易出现长痤疮、怕热出汗等症状。因此，惊蛰时要重视情志养生，力戒焦躁、抑郁等有害情绪，学会通过发泄和转移的方法使怒气消除，切忌妄动肝火。

(本文校对：王志华 收稿日期：2012-01-05)

开封市中医院便民措施受欢迎

【本刊讯】河南省开封市中医院始终多措并举方便患者，受到好评。

一是开设导医服务项目及预约挂号，方便病员就医；二是实行院长接待日制度，每天上午安排一位院领导或职能部门中层领导接待患者及其家属，受理病人投诉并处理主要事务；三是门诊大厅设置医院专家一览表、就医指南、价格公示、门诊专家坐诊时间公示，以便病员选择专家挂号就诊；四是行动不便的患者提供轮椅、开水、茶杯、报纸、电话、雨伞等；五是开辟“生命绿色通道”，实行24小时急诊，急危重症患者先抢救后办理手续；六是建立高效投诉机制，成立投诉办，公布投诉电话，设立投诉意见箱，向社会各界聘请监督员，利用各种形式接受社会监督。

(杨建宇 张文娟)